

TEMA 7.17 • PSIQUIATRÍA GENERAL

Trastornos Psicóticos: Trastorno Delirante, Esquizoafectivo y Psicosis Breve

PERFIL EUNACOM 4.01.1.001
Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Los trastornos psicóticos no se limitan únicamente a la **Esquizofrenia**. Existe un espectro de patologías donde el síntoma cardinal es la pérdida del juicio de realidad, pero con características clínicas, temporales y pronósticas distintas. En este artículo abordaremos el trastorno delirante, el trastorno esquizoafectivo y el episodio psicótico breve.

Trastorno Delirante (Paranoia)

La característica fundamental de este trastorno es la presencia de un **delirio sistematizado**. A diferencia de otros cuadros psicóticos donde el delirio puede ser caótico o fragmentado, aquí las ideas están "bien explicadas" y detalladas.

NOTA CLÍNICA

Fisiopatología del Delirio: El delirio es un conjunto de ideas apodícticas (certeza absoluta) que implican una pérdida del juicio de realidad. Se dice que es **sistematizado** cuando el paciente utiliza argumentos, datos o "pruebas" (aunque falsas o malinterpretadas) para dar estructura y lógica interna a su creencia.

Características principales:

- **Certeza Apodíctica:** El paciente tiene una seguridad total que no admite argumentos en contra.
- **Funcionalidad Preservada:** Es el rasgo más distintivo. El delirio está "encapsulado"; la persona puede trabajar y mantener relaciones sociales normales siempre que no se toque el tema del delirio.
- **Criterio Temporal:** - **Trastorno Delirante:** Mínimo **4 semanas** (1 mes). - **Trastorno Delirante Crónico:** Mínimo **3 meses**.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Si los síntomas duran menos de 4 semanas, el diagnóstico sigue siendo un **Episodio Psicótico Agudo**.

Diagnóstico Diferencial: Esquizofrenia vs. Trastorno Delirante

Es fundamental distinguir estas dos entidades, ya que el pronóstico y el compromiso de la personalidad difieren significativamente.

TABLA 7.17.1: CARACTERÍSTICA VS ESQUIZOFRENIA

CARACTERÍSTICA	ESQUIZOFRENIA	TRASTORNO DELIRANTE
Alucinaciones	Frecuentes (auditivas personificadas)	Ausentes o muy raras
Síntomas Negativos	Presentes (Aplanamiento, alogia)	Ausentes
Edad de inicio	Adolescencia / Adulto joven	Cualquier edad (frecuente en adultos mayores)
Funcionalidad	Deterioro global progresivo	Preservada (delirio circunscrito)
Historia Familiar	Frecuente antecedente genético	Menos vinculada a herencia directa

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

No confundir el Trastorno Delirante con los **Trastornos de Personalidad del Grupo A** (ej. Paranoide). En el trastorno de personalidad **no hay psicosis**; el sujeto es desconfiado pero no ha perdido el juicio de realidad ni tiene un delirio estructurado.

Tipos de Delirios Frecuentes

Los delirios pueden clasificarse según su temática principal:

- **Delirio Paranoide (Persecución):** Creencia de que existe un complot o que alguien lo está espiando (ej. la CIA, el gobierno).
- **Delirio de Celos (Celotipia):** Certeza absoluta de infidelidad, buscando "pruebas" irracionales en detalles cotidianos.
- **Delirio Erotomaniaco:** Creencia de que una persona (frecuentemente alguien famoso o de mayor estatus) está enamorada de ellos.
- **Delirio de Daño:** Convicción de que alguien específico (vecino, jefe) quiere perjudicarlo activamente.
- **Delirio Megalomaniaco (Grandiosidad):** Creencia de poseer poderes especiales (leer la mente, controlar animales) o ser una figura histórica/religiosa importante.
- **Delirio de Referencia:** Interpretar eventos externos neutros (noticias, gestos de extraños) como mensajes dirigidos específicamente al paciente.

NOTA CLÍNICA

El **Delirio Megalomaniaco** también puede verse en la **Manía** (Trastorno Bipolar), pero en la manía se acompaña de verborrea, fuga de ideas e insomnio, mientras que en el trastorno delirante el síntoma es puramente la idea fija.

Trastorno Esquizoafectivo

Este cuadro combina síntomas de la **Esquizofrenia** con síntomas de un trastorno del ánimo.

- **Clínica:** Los síntomas psicóticos y anímicos pueden ocurrir de forma simultánea, alternada o con intervalos muy cortos.
- **Subtipos:**
 - **Tipo Depresivo:** Episodios de psicosis más **Depresión Mayor**.
 - **Tipo Bipolar:** Episodios de psicosis más **Trastorno Bipolar** (manía o episodios mixtos).

Tratamiento:

El manejo debe atacar ambos frentes: 1. **Síntomas psicóticos:** Antipsicóticos. 2. **Síntomas anímicos:** - Si es tipo depresivo: Antidepresivos. - Si es tipo bipolar: Estabilizadores del ánimo (Litio, Valproato).

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

En el trastorno esquizoafectivo de tipo bipolar, el uso de antidepresivos está **contraindicado** por el riesgo de viraje a la manía.

Episodio Psicótico Breve

Se define por la aparición súbita de síntomas psicóticos (delirios, alucinaciones, lenguaje desorganizado) que duran **más de un día pero menos de un mes**.

- **Tipo Reactivo:** Cuando ocurre inmediatamente después de un evento altamente estresante (duelo, trauma).
- **Pronóstico:** Excelente, con recuperación total del nivel de funcionamiento previo.
- **Manejo Inicial:** Uso de antipsicóticos y, fundamentalmente, **descarte de organicidad**.

EUNACOM CRITERIOS

Ante un primer episodio psicótico, es obligatorio realizar un estudio básico para descartar causas médicas: - **Neuroimagen (TAC o RM):** Para descartar tumores o lesiones estructurales. - **Laboratorio:** Hemograma, electrolitos, pruebas hepáticas/renales. - **Test de Drogas en orina:** Para descartar psicosis inducida por sustancias.

Psicosis Posparto

Es una urgencia psiquiátrica que ocurre en el puerperio inmediato o tardío.

- **Pródromos:** Inquietud, insomnio, ansiedad extrema.
- **Clínica:** Delirios (a veces relacionados con el recién nacido), alucinaciones y gran desorganización conductual.
- **Manejo:** Es multidisciplinario. Requiere antipsicóticos (Haloperidol si hay mucha agitación, o atípicos orales) y vigilancia estrecha para proteger la integridad de la madre y el hijo. Siempre se debe descartar una causa orgánica subyacente (ej. infecciones postparto).

Trastornos del Ánimo Urgencias Psiquiátricas

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Hombre de 55 años sin antecedentes psiquiátricos refiere que su vecino lo odia y por eso hace ruido deliberadamente para molestarlo. Tiene pruebas de que el vecino lo sigue y hay marcas sospechosas en su auto. Trabaja bien, mantiene su familia y no tiene alucinaciones. ¿Cuál es el diagnóstico?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Trastornos Psicóticos: Trastorno Delirante, Esquizoafectivo y Psicosis Breve. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- El trastorno delirante: delirio sistematizado + sin alucinaciones prominentes + sin síntomas negativos + afecta solo un área de la vida.
- Trastorno delirante vs personalidad paranoide: el delirante Sí pierde el juicio de realidad (psicótico); la personalidad paranoide NO.
- Tipos de delirio: paranoide, celopático, erotomaniaco, de daño, megalomaniaco, de referencia.
- El trastorno esquizoafectivo combina síntomas psicóticos con síntomas afectivos simultáneos; el tratamiento combina antipsicótico + fármaco del ánimo.
- El episodio psicótico breve: dura 1 día a 1 mes + recuperación completa + frecuentemente reactivo; buen pronóstico.
- Toda psicosis nueva debe tener exámenes, neuroimagen y test de drogas para descartar causa orgánica.
- La psicosis posparto ocurre en el puerperio, precedida de insomnio e inquietud; manejo con antipsicóticos + buscar causa orgánica.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (TRASTORNOS PSICÓTICOS: TRASTORNO DELIRANTE, ESQUIZOAFECTIVO Y PSICOSIS BREVE)

PREGUNTA 1

Hombre de 55 años sin antecedentes psiquiátricos refiere que su vecino lo odia y por eso hace ruido deliberadamente para molestarlo. Tiene pruebas de que el vecino lo sigue y hay marcas sospechosas en su auto. Trabaja bien, mantiene su familia y no tiene alucinaciones. ¿Cuál es el diagnóstico?

- A)** Esquizofrenia paranoide; antipsicótico
- B)** Trastorno de personalidad paranoide; psicoterapia
- C)** Trastorno delirante crónico de tipo paranoide; antipsicótico atípico
- D)** Depresión con síntomas paranoides; ISRS
- E)** Trastorno adaptativo por conflicto con el vecino

PREGUNTA 2

Mujer de 30 años tiene episodios depresivos graves desde hace 2 años. En el último mes, simultáneamente con la depresión, ha desarrollado alucinaciones auditivas que le insultan. No ha tenido episodios maníacos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A)** Depresión psicótica; ISRS + antipsicótico
- B)** Trastorno esquizoafectivo tipo depresivo; antipsicótico + antidepresivo
- C)** Trastorno bipolar con síntomas psicóticos; estabilizador del ánimo
- D)** Esquizofrenia paranoide; antipsicótico solo
- E)** Trastorno delirante tipo depresivo; psicoterapia

PREGUNTA 3

Mujer de 26 años, que dio a luz hace 8 días, es traída por su esposo porque desde ayer habla sola, dice ver personas que no existen y está muy agitada. El parto fue vaginal sin complicaciones. ¿Cuál es el diagnóstico y conducta inicial?

- A)** Depresión posparto; iniciar ISRS
- B)** Psicosis posparto; antipsicóticos + descartar causa orgánica (meningitis, encefalitis)
- C)** Síndrome de baby blues; tranquilizar a la familia y observación
- D)** Trastorno de estrés agudo posparto; benzodiazepinas
- E)** Esquizofrenia de debut posparto; antipsicóticos sin más estudios

RESUMEN: TRASTORNOS PSICÓTICOS: TRASTORNO DELIRANTE, ESQUIZOAFECTIVO Y PSICOSIS BREVE

El trastorno delirante se define por la presencia de un delirio sistematizado (bien estructurado y explicado) sin alucinaciones prominentes ni síntomas negativos. El delirio afecta solo un área de la vida y no el funcionamiento global, a diferencia de la esquizofrenia. Para llamarlo trastorno delirante se requieren mínimo 4 semanas; para que sea crónico, mínimo 3 meses. Los tipos de delirio más frecuentes son: paranoide (me persiguen, hay un complot), celopático (infidelidad con certeza absoluta), erotomaniaco (alguien está enamorado de mí), de daño (alguien me quiere dañar deliberadamente) y megalomaniaco (tengo poderes especiales o soy alguien importante). La diferencia con la esquizofrenia es la ausencia de alucinaciones auditivas personificadas, de síntomas negativos y de antecedentes familiares de esquizofrenia. La diferencia con los trastornos de personalidad paranoide o celópata es la pérdida del juicio de realidad (el trastorno delirante Sí está psicótico). El trastorno esquizoafectivo combina síntomas psicóticos (similares a la esquizofrenia) con síntomas afectivos (del ánimo), que ocurren simultáneamente o de manera muy cercana. Se clasifica en tipo depresivo y tipo bipolar. El tratamiento combina antipsicóticos (para los síntomas psicóticos) con antidepresivos si es tipo depresivo, o estabilizadores del ánimo si es tipo bipolar. La depresión psicótica (primero depresión, luego se agrega psicosis) y la esquizofrenia que se deprime se diferencian del esquizoafectivo por el perfil temporal de los síntomas. El episodio psicótico breve dura entre 1 día y 1 mes, frecuentemente reactivo a un evento estresante, y se recupera por completo. Tiene buen pronóstico. Ante cualquier psicosis nueva o aguda sin causa clara se deben descartar causas orgánicas (infección, tumor cerebral, drogas) con exámenes, neuroimagen y test de drogas.